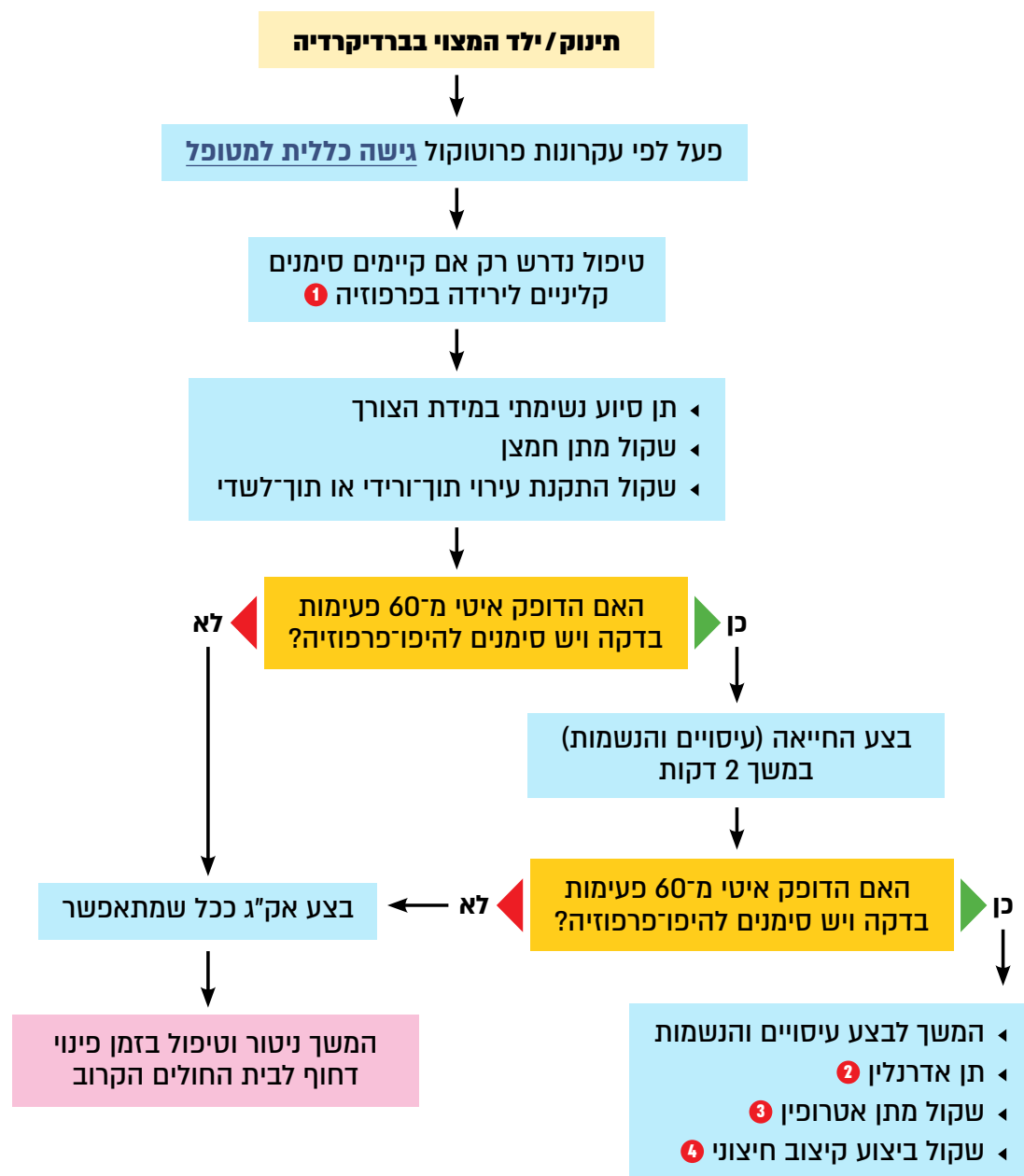




## 1 סימנים לירידה בפרפוזיה

- + ירידה במצב ההכרה.
- + סימני הלם.
- + לחץ הדם הסיסטולי נמוך מהערך התחתון המתאים לגיל המטופל.

## 2 אדרנלין

- + מתן ב- $1.V$  –  $0.01 \text{ mg/kg}$ , ניתן לחזור על המנה כל 3-5 דקות.
- + מינון למתן ב- $E.T$  –  $0.1 \text{ mg/kg}$  מהולים ב- $5 \text{ ml}$  סליין.
- + מינון מקסימלי למנה  $2.5 \text{ mg}$ .

## 3 אטרופין

- + מינון למתן ב- $1.V$  –  $0.02 \text{ mg/kg}$ .
- + מינון מינימלי למנה –  $0.1 \text{ mg}$ .
- + מינון מקסימלי למנה –  $0.5 \text{ mg}$ .
- + מינון למתן ב- $E.T$  –  $0.05 \text{ mg/kg}$ .
- + במקרים של גירוי וגאלי מוגבר (לדוגמה, הקאות, שיעול וכדומה).
- + במקרים של  $primary A-V block$ .

## 4 + סדציה במקרה של קיצוב חיצוני

- יש להשרות סדציה "ארוכת טווח" בחולה הנדרש לקיצוב חיצוני.
- תרופת הבחירה תהא קטמין, מתן ב- $1.V$ , במינון  $0.5-1 \text{ mg/kg}$ . אפשר לחזור על המנה לאחר כמה דקות ולפי הצורך.
- מומלץ לשלב את הקטמין עם דורמיקום ב- $1.V$ , במינון  $0.1 \text{ mg/kg}$ . אך בתנאי שלחץ הדם הסיסטולי של המטופל עולה על לחץ דם הסיסטולי המינימלי לגילו.

**אבחנה**

- + בעת בדיקת המטופל יש להתמקד בהערכת מצב הנשימה שלו, שכן לעיתים קרובות הברדיקרדיה בתינוקות ובילדים נגרמת עקב היפוקסמיה.
- + אין לעכב טיפול בחולה או פינויו לשם ביצוע אק"ג.

**טיפול****החייאה**

- + יש להתמקד בחמצון מיטבי של המטופל (באמצעות מתן חמצן בריכוז מקסימלי או באמצעות סיוע נשימתי לפי הצורך) בזמנית עם ביצוע עיסויים.
- + קצב העיסויים צריך להיות לפחות 100 לחיצות בדקה.
- + העיסוי יהיה רק עד עומק שליש בית החזה – כ־4 ס"מ בתינוקות ו־5 ס"מ בילדים.
- + בילדים בוגרים עד 5-6 ס"מ.
- + יחס עיסויים והנשמות – מטפל יחיד 2:30, בצוות של שניים 2:15.